

„Mam flashback — *to nie jest teraz*”

Retrospekcja emocjonalna (ang. *emotional flashback*): cofnięcie się w stan dziecka traumatyzowanego, bez wizualnego komponentu. Wstyd, panika, bezradność jakby miało się 5 lat.

CZAS: 5–20 min na pełny protokół **REALIZACJA:** codzienna gotowość + kryzys

ŹRÓDŁO: Walker (2013, *Complex PTSD: From Surviving to Thriving*, protokół 13 kroków); Ehlers & Clark (2000); Brewin (2014, *dual representation theory*); van der Kolk (2014)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **czym jest retrospekcja**: różnice między wzrokową, somatyczną, emocjonalną, węchowo-słuchową. W sekcji 02 — **protokół Walker** (13 kroków, kondensacja): rozpoznanie → bezpieczeństwo → ciało → granice → samowalidacja → powrót. Sekcja 03 — **twoja mapa wyzwaczy** i znaków ostrzegawczych. Sekcja 04 — plan przygotowania i ćwiczenia *poza* kryzysem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Retrospekcja (ang. *flashback*) *nie* jest „wspomnieniem” — jest **doświadczeniem**, ponownym, mimowolnym, intruzyjnym przeżywaniem traumy. Ciało i emocje reagują, *jakby* trauma działa się *teraz*. Ehlers i Clark (2000): retrospekcje wynikają z *fragmentarycznej pamięci traumatycznej* — wspomnienie nie jest zintegrowane z kontekstem (czas, miejsce, „to było wtedy, nie jest teraz”). Brewin (2014, *dual representation theory*): pamięć traumy ma dwa systemy — sensoryczny (S-rep, niewerbalny, automatyczny) i kontekstualny (C-rep, werbalny, świadomy); w retrospekcji aktywuje się głównie S-rep, bez integracji z C-rep. **Cztery formy retrospekcji:** (1) *wzrokowa* — obrazy, sceny; (2) *somatyczna* — ból, napięcie, mdłości *bez* obrazu; (3) *emocjonalna* — nagle ogarnia terror lub wstyd *bez* oczywistego powodu (Walker, 2013, *emotional flashback*); (4) *węchowo-słuchowa* — zapach lub dźwięk wyzwała kaskadę. W C-PTSD retrospekcje są **częstsze** i bardziej *chroniczne* niż w klasycznym PTSD — ze względu na wielokrotność i przewlekłość traumy. Pete Walker (2013, *Complex PTSD: From Surviving to Thriving*) zaproponował **protokół 13 kroków** wyjścia z retrospekcji emocjonalnej — jedna z najpopularniejszych metod w społeczności C-PTSD. Skrócona wersja: (1) „*Mam retrospekcję*” — nazwanie; (2) „*czuję strach, ale nie ma niebezpieczeństwa*”; (3) odzyskiwanie ciała (oddech 4-7-8, *grounding*); (4) granice (jeśli sytuacja wymaga); (5) samowalidacja — „*to ma sens, bo...*”; (6) powrót do dorosłego „ja”. Ehlers i Clark (2000): retrospekcje są *podtrzymywane* przez: fragmentaryczną pamięć, silne asocjacje bodźcowe (wyzwalacz → retrospekcja), negatywne oceny („*zwariowałem*”, „*nigdy nie wyzdrowieję*”), strategie kontroli, które *paradoksalnie* nasilają (tłumienie, unikanie). Klucz kliniczny: *praktyka poza kryzysem* — by protokół był dostępny w kryzysie. Klientka w środku spotkania rodzinnego, która *nie* rozpoznaje retrospekcji emocjonalnej, reaguje na siebie krytyką („*jestem dramatyczna*”) — sytuacja eskaluje. Klientka, która *rozpoznaje*: „*to retrospekcja, to nie jest teraz, mam protokół*” — przerywa eskalację.

01



Cztery formy retrospekcji

WZROKOWA

Obrazy, sceny. Klasyczna retrospekcja PTSD. Widzisz traumę „przed oczami”.

SOMATYCZNA

Ciało. Ból, napięcie, mdłości, duszność — *bez* obrazu. Często mylone z chorobą.

EMOCJONALNA

Walker. Nagle terror, wstyd, bezradność — *bez* powodu. „*Jakbym miał/-a 5 lat*”.

WĘCH / DŹWIĘK

Zapach lub dźwięk. Wyzwała kaskadę somatyczną i emocjonalną. Często niezidentyfikowany świadomie

02 Protokół 13 kroków (Walker, skrócony do 6)

KROK	DZIAŁANIE
1 · Nazwij	Powiedz głośno lub w myślach: „Mam retrospekcję. To jest retrospekcja.” Sam akt nazywania aktywuje korę przedczołową.
2 · Bezpieczeństwo	„Czuję strach, ale niebezpieczeństwo jest w przeszłości, nie tutaj i teraz.” Rozejrzyj się: gdzie jestem? Kto jest obok? Jaka jest data?
3 · Ciało	Oddech 4–7–8 (wdech 4 s, wstrzymanie 7 s, wydech 8 s). <i>Grounding</i> 5–4–3–2–1. Stopy świadomie na podłodze. Zimna woda na twarz, jeśli dostępna.
4 · Granice	Jeśli sytuacja jest aktywująca — odejdź. Wyjdź z pokoju, z rozmowy, z miejsca. Nie tłumacz się, nie przepraszaj. Granice są opieką.
5 · Walidacja	„To, co czuję, ma sens — bo kiedyś działo się to naprawdę i moje ciało pamięta. Nie jestem dramatyczny/-a. Nie wariuję.” Antidotum na zinternalizowanego krytyka.
6 · Powrót	Wróć do dorosłego „ja”. „Mam X lat, mieszkam tutaj, jestem bezpieczny/-a, mogę o siebie zadbać.” Konkretna czynność: woda, herbata, krótki spacer.

03 Moja mapa wyzwalaczy + plan

ZNAKI OSTRZEGAWCZE — MOJA SYGNATURA RETROSPEKCJI

— co najpierw odczuwam (somatycznie, emocjonalnie); zwykle 30–60 sek przed pełną retrospekcją

MOI TYPOWI „PODPALACZE”

— wyzwalacze (sytuacje, osoby, miejsca, dźwięki, zapachy); im więcej rozpoznam, tym wcześniej mogę zadziałać

PLAN NA SYTUACJE RYZYKOWNE

— np. święta rodzinne, wizyta u lekarza; jak przygotuję się wcześniej

PRAKTYKA POZA KRYZYSEM

— protokół ćwiczę raz dziennie, np. wieczorem; w kryzysie pamiętać nie sięga technik, które ćwiczę dopiero teraz

Klucz: retrospekcja emocjonalna (Walker, 2013) jest częstsza niż wzrokowa w C-PTSD — i *trudniejsza* do rozpoznania. Pacjent w środku spotkania rodzinnego nagle czuje wstyd, panikę, bezradność jakby miał 5 lat — bez wizualnego komponentu nie rozpoznaje, że to retrospekcja. Reaguje na siebie krytyką: „jestem dramatyczny/-a, przesadzam, co ze mną nie tak?”. To jest klasyczne wzmocnienie cyklu. Trening rozpoznawania retrospekcji emocjonalnych jest jednym z najważniejszych celów Fazy 1. *Rozpoznanie* jest połową interwencji — gdy nazwiesz „to retrospekcja, nie jestem 5-latką”, aktywujesz korę przedczołową, przerywasz eskalację. Trening protokołu *poza kryzysem* (raz dziennie, krótko) tworzy ścieżkę dostępną w kryzysie. Bez treningu — protokół „jest w handoutach”, ale niedostępny w momencie aktywacji.

△ Częste, długie, intensywne retrospekcje (kilka razy dziennie, ponad godzinę, z utratą kontroli nad czynnościami) mogą wskazywać na konieczność konsultacji psychiatrycznej i rozważenia farmakoterapii pomocniczo (np. prazosin w retrospekcjach nocnych). Linia wsparcia w kryzysie: 116 123 (dorośli), 116 111 (młodzież), codziennie 24/7.